

ODONTALGIA Y FLEMÓN

Raúl Antúñez-Conde, Gema Arenas de Frutos, Elena Salomé Bullejos Martínez, Samuel Espías Alonso, Pablo Montes Fernández-Micheltorena, Eduardo Monteserín Martínez, Marta Peña Barreno

INTRODUCCIÓN

La odontalgia o dolor de origen dentario es la causa más frecuente del dolor orofacial y supone un porcentaje importante de las urgencias ambulatorias.

En muchos casos encontraremos odontalgia asociada a la inflamación de los tejidos conjuntivos circundantes a una pieza dentaria, sin evidencia de colecciones pero con origen infeccioso. Esta inflamación se denomina flemón. Además, podremos encontrar casos de flemón sin odontalgia, si bien la causa del proceso será similar.

DIAGNÓSTICO

Pulpitis

Se trata de la inflamación del tejido pulpar dentario. Su principal causa es infecciosa (caries) aunque el origen también puede ser mecánico (bruxismo), físico (traumatismos, fisuras del esmalte), etc.

El elemento cardinal es el dolor, el cual se presenta de forma **espontánea**.

En las **pulpitis purulentas**, hay un aumento de **dolor nocturno**, debido al estasis circulatorio, a la posición horizontal y al aumento de temperatura.

Periodontitis

Se trata de la inflamación de los tejidos de soporte del diente. Se manifiesta como un dolor que **aumenta con la masticación**, **movilidad dentaria**, percusión dental muy dolorosa, **tumefacción de las encías** y feto oris.

Absceso periodontal

Se trata de una colección purulenta en el espacio periapical. El dolor a la masticación y a la percusión junto, en ocasiones, a la presencia de fiebre, movilidad dental, **“trismus”**, tumefacción de la zona afectada y, en algunos de los casos, aparición de una región inflamada y **fluctuante** con o sin trayecto fistuloso de drenaje espontáneo de material purulento, constituyen las manifestaciones clínicas fundamentales.

En casos en los que la exploración física ponga de manifiesto la presencia de **empastamiento** a nivel del suelo de boca, imposibilidad para la apertura oral pese a tratamiento o signos de disfagia y dificultad respiratoria, deberemos solicitar un TAC de cuello con contraste. En muchos casos, el tratamiento requerirá **drenaje quirúrgico**.

Alveolitis

Es un proceso infeccioso localizado en la pared del alvéolo dentario. El diagnóstico de alveolitis viene dado en general por la clínica del paciente: antecedente de extracción dental (1-3 días antes), presencia en el alvéolo de restos de comida, ausencia de coágulo en su interior, fetidez bucal y dolor que aparece a las 6-12 horas de realizada la exodoncia y que se hace cada vez más intenso.

Pericoronaritis

Consiste en la infección del saco pericoronario que rodea el diente. Se da con más frecuencia en los terceros molares, más aún en los inferiores. Cursa con dolor con irradiación a oído, cuello y amígdalas. En la inspección intrabucal encontramos una mucosa congestiva y turgente, dolorosa al tacto con secreción purulenta espontánea o a la presión.



Celulitis

Consiste en la progresión de la infección al tejido celular subcutáneo desde su origen dentario o peridentario, que provoca una tumefacción dura, difusa y molesta al paciente.

Los signos de alarma habituales son:

- Extensión a espacios celulares del cuello.
- Elevación del suelo de la boca.
- Dificultad en los movimientos deglutorios.
- Disfagia.
- Disnea.
- Trismus importante.

Manejo en urgencias

- **Clínica.** En función de la clínica del paciente nos plantearemos.
- **Analítica sanguínea:** hemograma, bioquímica básica con PCR, coagulación en caso de que tome ACOs o HBP.
- **Ortopantomografía.**
- **Antibioticoterapia:** suelen utilizarse antibióticos de amplio espectro como Amoxicilina-ácido clavulánico, Clindamicina y Metronidazol, así como otras combinaciones en función de las alergias y comorbilidades del paciente.
- **Analgesia.** AINES, corticoides, analgésicos inicial IV en urgencias, oral al alta.

TRATAMIENTO

- **Analgesia.** De acuerdo con la escala analgésica de la OMS, el primer escalón terapéutico lo constituyen el paracetamol y los AINES, siendo los más utilizados por su eficacia demostrada Ibuprofeno y Dexketoprofeno.

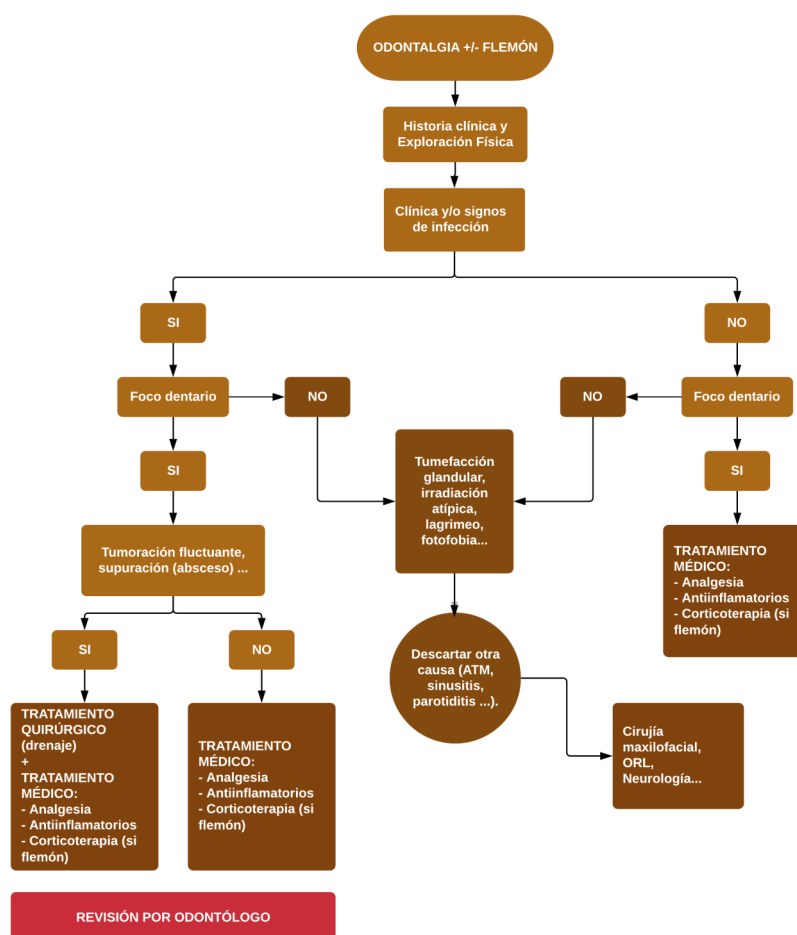
Como segundo escalón podremos utilizar opioide menor, que pueden prescribirse sólo si el paciente ya ha tomado AINES o paracetamol sin control del dolor. Codeína se debe considerar en primer lugar, si es insuficiente, el siguiente opioide a considerar es tramadol, luego opiodes mayores como morfina, oxicodona, etc.

Tramadol. Presenta menos efectos adversos que AINEs y opioides tradicionales.

- **Antibioterapia.** No existe evidencia de que la antibioterapia empírica produzca mejoría del dolor dental en los casos que no se sospecha causa infecciosa. Sin embargo, es de vital importancia instaurar tratamiento antibiótico cuando la sintomatología apunta a una infección o en casos en que el riesgo de la misma sea muy elevado.
 - Amoxicilina-clavulánico 875/125mg 1 cada 8 horas durante 7-10 días.
 - Clindamicina 600mg cada 8 horas durante 7-10 días en alérgicos a la penicilina.
 - Metronidazol 250mg: 500mg cada 8h durante 7 días.
- **Corticoides.** Los corticoides más utilizados en casos de inflamación facial con compromiso potencial de la vía respiratoria o de otras estructuras son la dexametasona, la metilprednisolona y el deflazacort. Los dos últimos pueden utilizarse por vía oral. Es por ello, la razón por la cual los pacientes con un importante flemón asociado al dolor dental son susceptibles de recibir una dosis elevada de corticoide en la Urgencia por vía intramuscular o intravenosa (Metilprednisolona 40mg) y una pauta descendente de corticoide oral (Deflazacort 30mg en pauta descendente).

Puntos clave

- Ante una pieza dentaria endodonciada, la ausencia de dolor no será valorable.
- Vigilar estrechamente aquellas celulitis localizadas en las regiones mandibular, sublingual, suprahiodea y las ubicadas en el espacio pterigomandibular debido a la posibilidad de compromiso de la vía aérea.
- Los mejores resultados para el tratamiento del dolor se consiguen mediante la asociación de corticoide con un AINE, de forma que el aquel controlaría el edema agudo y el AINE, el dolor.



BIBLIOGRAFÍA

- Pozos Guillén AJ, Aguirre Bañuelos P, Pérez Urizar J. Manejo clínico-farmacológico del dolor dental. ADM 2008;65(1):36-43.
- Metha NR, Scrivani SJ, Spierings LH. Dental and Facial Pain. En: Benzon HT, Rathmell JP (ed). Practical Management of Pain. 5ª ed. Philadelphia; Elsevier; 2014.
- Rodríguez Ruiz JA. Urgencias en Cirugía oral y Maxilofacial. Cádiz: Universidad, Servicio de Publicaciones; Madrid: Stratec Medical; 2003.